

Efectos adversos frecuentes y síndrome neuroléptico maligno

1. Introducción y relevancia clínica

Los psicofármacos, aunque fundamentales para el manejo de los trastornos mentales, **no están exentos de riesgos**.

El conocimiento de sus **efectos adversos** es esencial para prevenir complicaciones, mejorar la adherencia terapéutica y **detectar precozmente reacciones graves**.

Entre las más importantes se incluyen:

- **Efectos extrapiramidales** (por antipsicóticos).
- **Síndrome neuroléptico maligno (SNM)** —potencialmente mortal.
- **Efectos metabólicos** (obesidad, dislipidemia, resistencia a insulina).
- **Toxicidad por litio o valproato**.
- **Síndrome serotoninérgico** (por ISRS/IRSN).
- **Sedación y dependencia** (por benzodiacepinas).

□ En el **EUNACOM**, suelen presentarse preguntas del tipo:

“Paciente en tratamiento con haloperidol presenta fiebre, rigidez y confusión. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata?”

□ Respuesta esperada: *Síndrome neuroléptico maligno; suspender antipsicótico, manejo intensivo y dantroleno.*

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Los efectos adversos psicofarmacológicos derivan de la **acción sobre sistemas de neurotransmisores** más allá del efecto terapéutico deseado.

Sistema afectado

Consecuencia clínica

Dopaminérgico (D₂)

Efectos extrapiramidales, SNM

Serotoninérgico (5-HT)	Síndrome serotoninérgico, disfunción sexual
Colinérgico (M1)	Boca seca, constipación, visión borrosa, retención urinaria
Adrenérgico (α1)	Hipotensión ortostática, mareos
Histaminérgico (H1)	Sedación, aumento de peso
Endocrino/metabólico	Hiperprolactinemia, dislipidemia, resistencia insulínica

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Efectos adversos frecuentes según grupo farmacológico

Grupo	Efectos adversos comunes	Comentarios clínicos
ISRS / IRSN	Náuseas, insomnio, cefalea, disfunción sexual, ansiedad inicial, hiponatremia	Bien tolerados; seguros en sobredosis
Antipsicóticos típicos	Efectos extrapiramidales, sedación, hipotensión, hiperprolactinemia	Más riesgo de SNM
Antipsicóticos atípicos	Aumento de peso, dislipidemia, hiperglicemia, somnolencia	Clozapina y olanzapina los más obesogénicos
Litio	Tremor, poliuria, hipotiroidismo, intoxicación (náuseas, confusión, convulsiones)	Requiere monitoreo de litemia

Valproato	Aumento de peso, náuseas, hepatotoxicidad, trombocitopenia	Evitar en embarazo
Carbamazepina	Leucopenia, hiponatremia, hepatotoxicidad	Control con hemograma y perfil hepático
Benzodiacepinas	Somnolencia, dependencia, caídas, depresión respiratoria	Uso corto (máx. 4-6 semanas)

3.2. Síndrome neuroléptico maligno (SNM)

Definición:

Emergencia psiquiátrica aguda caracterizada por **hipertermia, rigidez muscular y alteración del sensorio**, desencadenada por antipsicóticos o suspensión brusca de agonistas dopaminérgicos.

Incidencia:

0,02–3% de los pacientes expuestos a neurolépticos. Mortalidad: 10–20%.

Fisiopatología:

Bloqueo masivo de receptores D₂ dopaminérgicos en el sistema nigroestriado y hipotálamo → disautonomía, rigidez, hipertermia e inestabilidad autonómica.

3.3. Clínica del SNM

Sistema	Manifestaciones
Neuromuscular	Rigidez “en tubo de plomo”, hipertonía generalizada, temblor, mutismo
Autonómico	Fiebre (>38,5°C), taquicardia, hipertensión o hipotensión, diaforesis

Neurológico Confusión, estupor, delirio, coma

Laboratorio ↑ CPK (>1000 UI/L), leucocitosis, alteración hepática y renal, mioglobinuria

Inicio: horas a días tras inicio o aumento de dosis de antipsicótico.

Duración: 5–14 días (más si no se suspende el fármaco).

3.4. Diagnóstico diferencial del SNM

Entidad	Diferenciador
Síndrome serotoninérgico	Mioclonías, hiperreflexia, inicio rápido, asociado a ISRS
Catatonía maligna	Historia psiquiátrica previa, sin uso de antipsicóticos
Hipertermia maligna (anestesia)	Exposición a halogenados o succinilcolina
Infecciones del SNC / sepsis	Signos meníngeos, foco infeccioso evidente

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes de laboratorio sugeridos

- **CPK sérica:** elevada > 1000 UI/L (indicador de daño muscular).
- **Hemograma:** leucocitosis con neutrofilia.
- **Función renal:** creatinina y BUN (riesgo de rabdomiólisis).

- **Electrolitos:** hiponatremia, hipocalcemia.
- **Función hepática:** elevación leve de transaminasas.
- **EGO:** mioglobinuria.
- **TAC o RM cerebral:** descartar causas neurológicas alternativas.

4.2. Criterios diagnósticos (DSM-5)

Diagnóstico clínico basado en:

1. Uso reciente de antipsicóticos.
2. Fiebre > 38°C.
3. Rigidez muscular grave.
4. Alteración del sensorio o disfunción autonómica.
5. CPK elevada u otras evidencias de daño muscular.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile y recomendaciones internacionales)

El manejo del SNM es **una urgencia médica**, y requiere suspensión inmediata del fármaco y medidas de soporte vital.

5.1. Conducta inicial

1. **Suspender antipsicótico o agente causal.**
 2. **Traslado a unidad de cuidados intensivos (UCI).**
 3. **Monitorización de signos vitales, líquidos y diuresis.**
 4. **Control de hipertermia:** enfriamiento externo, paracetamol (no dantroleno inicialmente).
 5. **Hidratación intensiva:** evitar falla renal secundaria a rabdomiólisis.
-

5.2. Tratamiento farmacológico

Fármaco	Dosis orientativa	Mecanismo
Dantroleno IV	1–2,5 mg/kg cada 6 h	Relaja músculo esquelético, ↓ hipertermia
Bromocriptina VO o sonda	2,5–10 mg cada 8 h	Agonista dopaminérgico, revierte bloqueo D ₂
Amantadina	Alternativa si bromocriptina no disponible	Estimula liberación de dopamina
Benzodiacepinas	Lorazepam 1–2 mg IV c/6 h	Sedación y control de agitación

☐ La combinación **dantroleno + bromocriptina** reduce la mortalidad a menos del 5%.

5.3. Medidas de soporte

- Control estricto de la temperatura (<38°C).
 - Vigilar diuresis (objetivo > 1 ml/kg/h).
 - Monitorear CPK seriada y función renal.
 - Fisioterapia pasiva y movilización temprana.
 - Reintroducir antipsicóticos solo **2 semanas después** de la resolución, preferiblemente **atípicos (quetiapina, clozapina)**.
-

5.4. Prevención

- Aumentar dosis de antipsicóticos gradualmente.
- Evitar combinaciones de fármacos con acción dopaminérgica.

- Hidratar adecuadamente a los pacientes.
 - Controlar la temperatura y vigilar rigidez.
 - Educar al paciente y familia sobre signos de alarma.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones del SNM

- Rabdomiólisis → insuficiencia renal aguda.
- Trastornos hidroelectrolíticos.
- Neumonía aspirativa.
- Trombosis venosa profunda por inmovilización.
- Recaída si reintroducción precoz del antipsicótico.

Pronóstico

- Mortalidad: 10–20% si no se trata oportunamente.
 - Con tratamiento intensivo adecuado, la mayoría se recupera sin secuelas.
 - Reaparición: 10–30% si se reintroduce neuroléptico antes de 2 semanas.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. El **SNM** es una **emergencia psiquiátrica vital**.
2. Se asocia con **bloqueo dopaminérgico masivo**, especialmente con haloperidol y flufenazina.

3. Los síntomas cardinales: **fiebre, rigidez y alteración mental**.
 4. **CPK elevada** confirma el diagnóstico, pero no es obligatoria.
 5. El manejo inicial es **suspender el fármaco y soporte intensivo**.
 6. **Dantroleno + bromocriptina** son las opciones terapéuticas específicas.
 7. No reiniciar antipsicóticos antes de **2 semanas post recuperación**.
 8. En **EUNACOM**, distinguirlo del **síndrome serotoninérgico** es una pregunta recurrente.
-



Errores comunes

- No reconocer el cuadro como una urgencia vital.
 - Confundirlo con infección o síndrome serotoninérgico.
 - Continuar el antipsicótico o no suspenderlo de inmediato.
 - No realizar hidratación intensiva ni control de CPK.
 - Reiniciar el fármaco prematuramente.
 - Usar antipsicóticos típicos nuevamente tras el episodio.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **efectos adversos de psicofármacos** son frecuentes y pueden ser graves si no se detectan precozmente.
2. El **síndrome neuroléptico maligno (SNM)** es la reacción más severa al bloqueo dopaminérgico: **fiebre, rigidez, confusión, CPK alta**.
3. El manejo requiere **suspender el antipsicótico, hidratación intensiva y tratamiento con dantroleno o bromocriptina**.

4. El **síndrome serotoninérgico** (por ISRS/IRSN) es un diagnóstico diferencial importante (hiperreflexia y mioclonías).
5. **Monitorear periódicamente** peso, glicemia, función hepática y renal en todo paciente en tratamiento prolongado.
6. La **prevención y educación** del paciente son claves para reducir la morbilidad y mejorar adherencia.
7. En EUNACOM, siempre priorizar la **detección del SNM y su manejo inicial correcto**.